

Tu adolescente autista

Para padres y cuidadores familiares — apoyar a un adolescente autista (aproximadamente de 12 a 18 años).

la idea principal {././lead}

El autismo, a través del **monotropismo**, significa que la atención de su adolescente se concentra en unos pocos «túneles» profundos e intensos. La adolescencia acumula demandas multi-canal —cambios en las reglas sociales, citas, cambios corporales, exámenes— sobre un sistema para el cual el cambio rápido es costoso. Esta es la **edad crítica para la ansiedad, la depresión y el burnout**, y muchos adolescentes autistas (especialmente las niñas y géneros marginalizados) son **identificados por primera vez solo en situación de crisis**. Sus intereses intensos son identidad, regulación y recuperación, no problemas. Su trabajo cambia de gestionar a *acompañar*: siga su ejemplo, proteja su focalización, reduzca la carga y tome en serio su vida interior.

Lo que puede observar — y lo que realmente está sucediendo

Puede observar...	Lo que suele suceder
Agotado, retraído, «no tiene ganas»; rechaza ir a la escuela	Probable burnout autístico o sobrecarga — distinto de la depresión y la pereza
Intereses intensos; se resiste a dejarlos	Los intereses son identidad, regulación y recuperación — no obsesiones
«Está bien» todo el día, colapsa tras cerrar la puerta de su cuarto	Camuflaje pesado; el coste se paga más tarde, en casa
Autolesiones, pensamientos oscuros o crisis	Riesgo real y elevado en este grupo; a menudo es la primera señal de una necesidad no satisfecha
Lento para empezar/cambiar; no responde a las preguntas	Inercia autística + tiempo de procesamiento, no es mala educación ni «falta de interés»

Intente esto

- **Proteja y valide sus intereses** — nunca limite una pasión saludable; es su principal regulador y una ruta hacia el estudio, los amigos y la recuperación.
- **Cree un espacio para el desmasquar (*unmasking*) en casa** — el hogar es el lugar seguro donde la máscara del día escolar finalmente cae. Espere un colapso después de la escuela; prevea tiempo tranquilo, de baja demanda y guiado por sus intereses.
- **Reduzca las exigencias cuando la energía esté al límite**. Si están sufriendo un burnout, la medida basada en la evidencia es **reducir las expectativas y restaurar el descanso y los intereses**, no presionar más.
- **Comunique littéralmente, un elemento a la vez**, a menudo por escrito o mensaje de texto; deje tiempo de procesamiento; respete su autonomía en las decisiones.
- **Pregunte directamente** sobre el estado de ánimo, la ansiedad, el sueño y los pensamientos suicidas usando preguntas concretas — y escuche la respuesta.
- **Abogue en la escuela** (coordinador de necesidades especiales, plan de educación individualizado, espacio tranquilo, menos transiciones) y planifique

la transición a los servicios para adultos temprano.

Evite esto

- Confundir el **burnout autístico con la depresión** — tratarlo como «haz un esfuerzo» puede agravarlo y aumentar el riesgo de suicidio.
- Presionar para que hagan contacto visual, que camuflen o que «sean más sociales» como un objetivo.
- Acumular actividades, planes sociales y expectativas cuando ya están agotados.

Cuándo buscar más apoyo

El burnout autístico es real, serio y distinto — agotamiento crónico, pérdida de habilidades y reducción de la tolerancia a los estímulos; puede durar meses y está vinculado a pensamientos suicidas. Las **co-ocurrencias de ansiedad, depresión, TDAH (AuDHD), dificultades de sueño y alimentación** son comunes y merecen cuidados informados sobre el autismo. Busque un clínico positivo hacia el autismo, grupos de pares y mentores — una amistad de alta calidad es poderosamente protectora.

Si su adolescente es una niña o de género marginalizado

El camuflaje llega a su punto máximo aquí y provoca muchos diagnósticos perdidos y costes en la salud mental. La adolescente «ansiosa, perfeccionista, sociable en la superficie» puede ser una joven autista agotada. Pregunte específicamente sobre el **agotamiento por camuflaje** y tome en serio un patrón de diferencia a lo largo de la vida.

Acerca de esta guía

Asistida por IA, derivada de los borradores de investigación del proyecto — la **Guía para la familia** (Partes 1 y 4) y la brève sobre el **Monotropismo**, con el **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Partie 3.3). Utiliza el lenguaje de identidad primero.

Informativo — **no es un consejo médico ni una herramienta de diagnóstico**. Usted conoce mejor que nadie a su adolescente; adapte esto a él/ella.

Fuentes clave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020, burnout); Pearson & Rose (2021, masking); Bradley et al. (2021, camouflaging); Edgar (2024). Las citas completas están en los borradores fuente.